

Это операция по устранению рубцового сужения шейки мочевого пузыря или места соединения мочевого пузыря с уретрой после операции на простате — выполняется только через эндоскоп, без наружных разрезов. Хирург рассекает рубец и пришивает здоровую слизистую поверх него, чтобы зона заживала открытой.

Об этой процедуре

После операции или лучевой терапии на простате может образоваться рубец в области **шейки мочевого пузыря**, который затрудняет мочеиспускание. Простое рассечение рубца часто не помогает надолго: зона заживает поверх необработанной рубцовой ткани и сужается снова.

Метод **TUITMR** (трансуретральное рассечение с поперечной репозицией слизистой) решает эту проблему:

- Хирург **рассекает рубец** через эндоскоп, открывая просвет.
- Затем с помощью специального **инструмента для наложения швов** здоровая слизистая переводится и подшивается поверх разреза — как лоскутная пластика, но через уретру.

Ранние результаты обнадеживают: около **9 из 10** пациентов сохраняют открытый просвет после одной процедуры, почти все — после второй, при минимальном риске нового недержания.

Это безопасно?

Операция выполняется полностью через уретру, без открытого или роботизированного вмешательства. Ранние данные обнадеживают: низкий риск нового недержания мочи, которое может осложнить другие виды пластики в этой зоне.

Возможные риски: кровотечение, инфекция мочевыводящих путей (UTI), рецидив сужения. Это современная специализированная методика.

ТЕРМИНЫ

Шейка мочевого пузыря

Выход мочевого пузыря, переходящий в уретру.

Контрактура шейки мочевого пузыря

Рубцовое сужение шейки, затрудняющее мочеиспускание.

Анастомотический стеноз

Рубцовое сужение в зоне соединения мочевого пузыря с уретрой после операции на простате.

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из организма.

Слизистая

Здоровая внутренняя выстилка, перемещаемая поверх рубца для его открытого заживления.

Цистоскоп

Тонкая камера, через которую работает хирург.

Недержание мочи

Непроизвольное подтекание мочи — риск, который этот метод стремится свести к минимуму.

Катетер

Мягкая трубка, оставляемая в уретре на короткое время для заживления.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Процедура выполняется под анестезией — во время неё вы ничего не почувствуете. После возможны лёгкое жжение и розоватая моча в течение нескольких дней. Катетер оставляют на короткое время. Большинство пациентов уходят домой в тот же день или после короткого пребывания.

Как подготовиться (до процедуры)

- Операция проводится под **общей анестезией** — соблюдайте все предоперационные инструкции (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты).
- **Анализ мочи** исключает инфекцию — при её наличии сначала проводится лечение.
- Рассчитывайте на **катетер на несколько дней** и организуйте поездку домой.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете текущую инфекцию мочевыводящих путей
- Перенесли **операцию на простате, лучевую терапию** или ранее получали лечение в этой области

Что происходит во время процедуры

- 1 Вы находитесь под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Через уретру к рубцу подводится эндоскоп, устанавливается направляющая струна.
- 3 Рубец расширяют и рассекают, открывая просвет.
- 4 С помощью инструмента для наложения швов, проведённого через уретру, здоровую слизистую перемещают и подшивают поверх разреза; оставляют катетер.

После процедуры

- Вы уходите домой **в тот же день или после короткого пребывания** с катетером на несколько дней.
- Ожидайте **лёгкого жжения и розовой мочи** в течение нескольких дней. Пейте больше воды.
- **Избегайте тяжёлых нагрузок и натуживания** несколько недель.
- Контрольная эндоскопия (примерно через **4 месяца**) подтверждает, что просвет сохраняется открытым.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- **Невозможность помочиться**, особенно после удаления катетера
- Новое выраженное **недержание мочи**
- Сильное кровотечение, кровяные сгустки или нарастающая боль

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Это безразрезная пластика рубца шейки мочевого пузыря: рубец рассекают и закрывают здоровой слизистой для открытого заживления при низком риске недержания.
2. Подготовка: соблюдайте голодание и режим приёма лекарств, вылечите инфекцию заранее, рассчитывайте на катетер и организуйте поездку домой.
3. Лёгкое жжение и розоватая моча в первые дни — норма. Контрольная эндоскопия подтвердит успех. При повышении температуры, невозможности помочиться, новом сильном недержании или кровотечении — немедленно обратитесь к врачу.